



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Funcional · Nutricional · Psicossocial

Saúde do Idoso

Avaliação Geriátrica Ampla (AGA)

Avaliação Funcional, Nutricional e Psicossocial

TEMA	AGA: avaliação funcional, nutricional e psicossocial
AUTOR	Prof. Dr. Igor Moraes — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	35 minutos
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

“Doutor, é só fraqueza da idade” — e o que a consulta tradicional não vê?



Sra. M., 82 anos

Multimorbidade: HAS, DM2, artrose.

Veio “porque está mais devagar e cansada”.

PA, glicemia e exames: “dentro do esperado”.

O que a queixa esconde:



Deixou de cozinhar e pegar ônibus (perda de AIVD)



Perdeu 4 kg em 3 meses (risco nutricional)



Não sente mais prazer nas coisas (humor)



Mora sozinha; filha distante (suporte frágil)

Pergunta-gancho: quantos diagnósticos importantes ficaram fora da consulta “normal”?

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final, você aplica e interpreta as três dimensões da AGA



Justificar

1

por que a avaliação multidimensional supera a consulta tradicional — ligando funcionalidade a desfechos.



Aplicar — Funcional

2

Katz/Barthel (ABVD), Lawton/Pfeffer (AIVD) e mobilidade/quedas (TUG, SPPB, Tinetti).



Aplicar — Nutricional

3

MAN/MNA + IMC + circunferência da panturrilha; classificar risco e desnutrição.



Avaliar — Psicossocial

4

humor (EGD/Yesavage-15) e suporte social (APGAR da família, Zarit); ver o atípico.



Selecionar o cenário

5

ambulatorial × hospitalar e propor uma AGA breve no hospital de transição.

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz final.

Seis paradas: do porquê às três dimensões e ao cenário de aplicação



Vou retomar este mapa entre os blocos para você saber sempre onde estamos.

A geriatria deslocou o foco da doença para a funcionalidade



O Brasil envelhece rápido — e a demanda por avaliação funcional cresce junto

32,1 mi

pessoas com 60+ anos

15,6%

da população (era 10,8% em 2010)

+56%

de idosos em 12 anos

80

idosos p/ 100 crianças (índice de envelhecimento)

População 60+ (milhões) — Censos IBGE



Fonte: IBGE, Censo 2022.



Implicação para a prática

Mais idosos com multimorbidade chegam ao consultório, à enfermaria e ao hospital de transição. Sem uma avaliação multidimensional, esses problemas funcionais passam despercebidos — exatamente como na Sra. M.

3 • CONCEITO-CHAVE

Funcionalidade é o desfecho que importa — não a lista de doenças

Senescência → Senilidade → Fragilidade → Incapacidade



Robusto

Envelhecimento fisiológico; reserva preservada



Em risco

Reserva reduzida — janela de prevenção



Frágil

Declínio funcional estabelecido; alta vulnerabilidade



A AGA mede a funcionalidade em sistemas funcionais principais:



Cognição



Humor



Mobilidade



Comunicação

Hoje: Mobilidade (funcional) + estado nutricional + Humor e suporte social.

Rastreie a vulnerabilidade primeiro; aprofunde com a AGA quando houver risco

Gatilhos de alerta (red flags)



Perda funcional recente (parou de fazer o que fazia)



Emagrecimento não intencional



Polifarmácia (≥ 5 medicamentos)



Quedas, internações ou delirium



Isolamento social / morar só



Rastreio rápido: IVCF-20

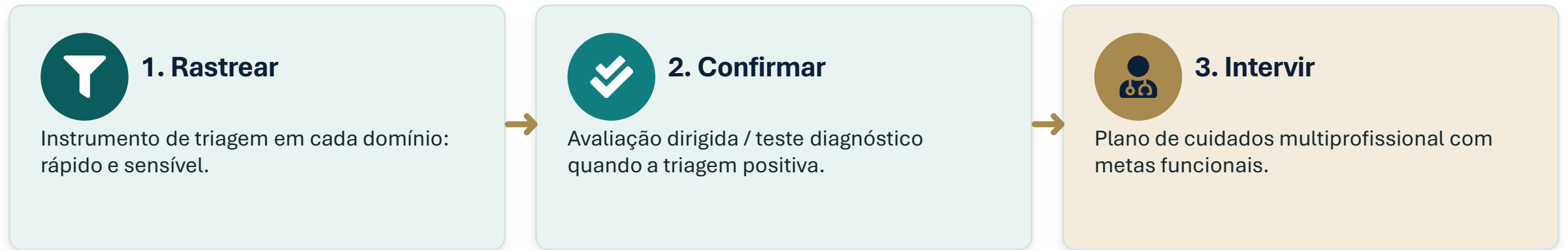
Instrumento brasileiro, 20 perguntas, qualquer profissional. Identifica idoso em risco de fragilização e idoso frágil.³



AGA: avaliação aprofundada

Positivou o rastreio? Aprofunda nas dimensões — funcional, nutricional e psicossocial — para construir o diagnóstico e o plano.

AGA é um processo em três passos: rastrear → confirmar → intervir



Domínios da AGA (SBGG) — em destaque, os de hoje:



Funcional



Nutricional



Humor



Suporte social



Cognição



Sensorial



Medicamentos



Mobilidade/quedas

Funcionalidade é o “sinal vital” do idoso — e as AIVD caem primeiro

AIVD — Atividades Instrumentais

Vida em comunidade — perdem-se PRIMEIRO

- Usar telefone
- Fazer compras
- Preparar refeições
- Tarefas domésticas
- Lavar roupa
- Transporte
- Medicamentos
- Finanças

ABVD — Atividades Básicas

Autocuidado — perdem-se DEPOIS (dependência maior)

- Banho
- Vestir-se
- Uso do banheiro
- Transferência
- Continência
- Alimentar-se

Regra de ouro: pergunte sempre “o que ele deixou de fazer?” — a perda de AIVD é o sinal de alarme mais precoce.

Para ABVD: Katz dá o retrato rápido; Barthel gradua a intensidade



Índice de Katz

6 atividades · independente (0) × dependente (1).
Escore 0 = totalmente independente; 6 = totalmente dependente.

Avalie o DESEMPENHO real (o que faz), não a habilidade declarada.

Rápido à beira-leito e ótimo para acompanhar evolução no internamento.



Índice de Barthel

0–100 — gradua a intensidade da dependência:

100

Independente

60–95

Dependência leve

40–55

Dependência moderada

20–35

Dependência grave

< 20

Dependência total

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Katz 1963; Mahoney & Barthel 1965.

Para AIVD: Lawton mede o que a pessoa faz; Pfeffer ouve o informante



Escala de Lawton-Brody

9 atividades instrumentais; cada item 1–3 pontos.

Escore 9–27:

25–27

Independente

10–24

Parcialmente dependente

9

Totalmente dependente



Questionário de Pfeffer

Respondido por familiar/cuidador (informante).
Sensível a declínio funcional ligado a demência.

< 6

Normal

≥ 6

Comprometido

Dica: Lawton e Pfeffer se complementam — desempenho observado + olhar de quem convive.

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Lawton & Brody 1969; Pfeffer 1982.

Três testes objetivos dizem quem tem maior risco de cair



TUG — Timed Up and Go

Levantar, andar 3 m, voltar e sentar. $\geq 12\text{--}20$ s sinaliza maior risco de quedas.



SPPB

Equilíbrio + velocidade da marcha + sentar-levantar 5x. Escore baixo = pior desempenho físico.



Tinetti (POMA)

Equilíbrio e marcha; quanto menor o escore, maior o risco de queda.



Queda não é “normal da idade”. Toda queda no último ano é red flag: investigue causas, medicamentos e ambiente. A queda prediz nova queda, fratura e perda de independência.

Você aplicou o funcional na Sra. M. — e agora?



Achados funcionais

- Katz 0 (independente nas básicas)
- Lawton 16 (parcial) — parou de cozinhar e usar ônibus
- TUG 16 s — risco aumentado de quedas
- 1 queda no último ano

Qual a melhor leitura?

A

“É da idade”: orientar repouso e reavaliar em 1 ano

B

Declínio instrumental + risco de queda: investigar causas e iniciar plano (reabilitação, revisão de fármacos, ambiente)

C

Solicitar tomografia de crânio antes de qualquer conduta

Resposta: B — a conduta muda antes de qualquer exame.

Rastreie nutrição com a MAN, apoiada por IMC e circunferência da panturrilha



Mini Avaliação Nutricional (MAN/MNA)

Triagem + avaliação global; instrumento mais usado no idoso.

≥ 24

Estado nutricional normal

17–23,5

Risco de desnutrição

< 17

Desnutrido

Pontuação da versão completa da MAN (triagem + avaliação global).

Medidas objetivas de apoio



Perda de peso não intencional

$\geq 5\%$ em 3–6 meses é sinal de alarme



IMC

Idoso: faixa de corte mais alta que no adulto



Circunferência da panturrilha

< 31 cm sugere baixa massa muscular (sarcopenia)

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Guigoz/Vellas (MNA).

Desnutrição não é “magreza”: separe-a da sarcopenia



Desnutrição

- Déficit de energia/proteína e micronutrientes
- Pode ocorrer com IMC normal ou alto
- Rastreio: MAN, perda de peso, ingesta
- Conduta: aporte calórico-proteico, tratar causas (boca, deglutição, depressão)



Sarcopenia

- Perda de massa E força/função muscular
- Panturrilha baixa, força de preensão ↓, marcha lenta
- Rastreio: SARC-F, dinamometria, velocidade da marcha
- Conduta: exercício resistido + proteína; é potencialmente reversível

Coexistem com frequência (desnutrição agrava sarcopenia) — avalie as duas.

Psicossocial = humor e suporte social caminham juntos



HUMOR

Depressão é comum, subdiagnosticada e tem apresentação atípica no idoso. Rastreio: EGD/Yesavage-15.



SUORTE SOCIAL

A rede sustenta o cuidado e a adesão. Avalie família (APGAR), cuidador e sobrecarga (Zarit).

Os dois se influenciam: rede frágil piora o humor; humor rebaixado isola ainda mais.

Depressão no idoso se disfarça — rastreie com a EGD/Yesavage-15



Escala de Depressão Geriátrica (15 itens)

≤ 5

Normal

≥ 7

Provável depressão

≥ 11

Depressão moderada a grave

Versão validada e prática; existe ainda a EGD-5 para triagem ultrarrápida.

Apresentação atípica — não espere tristeza clássica:



Queixas somáticas (dor, fadiga, insônia)



“Pseudodemência”: parece declínio cognitivo



Anorexia e perda de peso



Anedonia e perda de iniciativa, sem dizer “triste”

Fonte: instrumento AGA-SBGG; Yesavage 1982; validação BR Almeida & Almeida 1999.

O idoso é tão forte quanto sua rede: avalie família, cuidador e sobrecarga



APGAR da Família

- 5 itens: Adaptação, Participação, Crescimento, Afeto, Resolução
- > 6: boa funcionalidade familiar
- 4–6: disfunção moderada · < 3: disfunção acentuada



O cuidador importa

- Vínculo (formal/informal), conflitos e capacidade
- Rastrear sinais de abuso/negligência
- Quem cuida do cuidador?



Sobrecarga: Zarit

- Mede a sobrecarga do cuidador
- Sobrecarga alta → risco para o idoso e para o cuidador
- Gatilho para apoio e rede formal

Fonte: instrumento AGA-SBGG; APGAR de Smilkstein 1978; Zarit 1980.

As três dimensões se somam no diagnóstico funcional global



Funcional

Perda de AIVD + TUG 16 s + 1 queda → declínio instrumental e risco de quedas



Nutricional

Perda de 4 kg + MAN em faixa de risco → risco nutricional



Humor

Anedonia + perda de peso + EGD elevada → provável depressão



Social

Mora só, filha distante, APGAR baixo → suporte frágil



Diagnóstico funcional global

Idosa em risco de fragilização, com declínio instrumental, risco nutricional, provável depressão e suporte social frágil → plano multiprofissional integrado.

A AGA só vale se vira plano — e o plano gera desfecho funcional

Plano de cuidados multiprofissional



Médico: revisar fármacos, tratar depressão, metas



Fisioterapia: reabilitação, marcha, quedas



Nutrição: aporte proteico-calórico



Serviço social: rede e cuidador



Fono/TO: deglutição e AVD



Evidência (forte)

AGA hospitalar ↑ a chance de o idoso estar **vivo e no próprio domicílio** no seguimento.

RR ~1,06 (IC95% 1,01–1,10) vivo e em casa.

Pouca/nenhuma diferença na mortalidade (RR 1,00).

Desfecho que importa no idoso = funcionalidade e independência, não só sobrevida.

Fonte: Ellis G, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017;CD006211 (29 ensaios; 13.766 participantes).

“Menos é mais”: a AGA também protege o idoso do excesso de medicina



O que evitar (iatrogenia)

- Cascata de prescrição e polifarmácia
- Exames e rastreios sem benefício na expectativa de vida
- Metas rígidas (PA/glicemia) que causam queda e hipoglicemia
- Intervenções que não respeitam metas do paciente



A AGA orienta a proporcionalidade

- Individualiza metas pela funcionalidade e prognóstico
- Apoia a desprescrição (Beers/STOPP-START)
- Prioriza funcionalidade e qualidade de vida
- Alinha o cuidado ao que importa para o idoso

A AGA completa é, por excelência, ambulatorial — no hospital agudo ela tem limites



Ambulatório — cenário ideal

- Paciente estável: desempenho “real” mensurável
- Tempo e múltiplas consultas para avaliação completa
- Longitudinalidade: dá para acompanhar a evolução
- Foco em prevenção e manutenção da funcionalidade



Hospital agudo — limitações

- Doença aguda e delirium distorcem o desempenho real
- Acamado/restrito: escalas funcionais subestimam a basal
- Tempo curto, prioridade na estabilização clínica
- Risco de “rótulo” de dependência que era transitória

Regra prática: no agudo, registre a funcionalidade BASAL (pré-internação) e reavalie após estabilizar.

Façam a AGA breve no hospital de transição: a janela perfeita

Paciente já estabilizado + tempo de permanência + meta de alta = o cenário ideal para avaliar e agir.



Janela ideal

Pós-fase aguda: o desempenho já reflete a capacidade real e modificável



Tempo a favor

A permanência permite avaliação completa e reavaliação seriada



Direciona a reabilitação

Define metas funcionais objetivas para a equipe multiprofissional



Planeja a alta segura

Antecipa rede, cuidador e adaptações — reduz reinternação



Otimiza fármacos

Momento de ouro para desprescrição e ajuste de metas



Mede resultado

Barthel/Lawton na entrada e na saída mostram o ganho funcional

O erro nº 1: avaliar a habilidade declarada em vez do desempenho real



A armadilha

Perguntar “a senhora consegue tomar banho?”

→ ela diz “consigo”, mas há meses a filha dá banho.

Katz/Barthel medem DESEMPENHO REAL, não habilidade.



Como evitar

- Pergunte “quem faz?” e “como foi a última vez?”
- Confirme com o informante (Pfeffer)
- Observe quando possível; cuidado com superproteção



Curiosidade: a geriatria moderna nasce nos anos 1930 com Marjory Warren, que ao reavaliar “incuráveis” e reabilitá-los provou que avaliação funcional muda destino — a origem da própria AGA.

Leve três ideias e uma frase para a vida

O idoso se mede pelo que ele **FAZ** · **COME** · e com **QUEM CONTA**

FAZ = funcional · COME = nutricional · COM QUEM CONTA = psicossocial (humor + suporte)



Funcionalidade é o sinal vital

AIVD caem primeiro; meça desempenho real (Katz/Barthel/Lawton) e quedas (TUG).



Nutrição salva função

MAN + perda de peso + panturrilha; desnutrição ≠ magreza; some sarcopenia.



Humor e rede mudam o plano

Depressão é atípica (EGD-15); avalie família e cuidador (APGAR, Zarit).

Teste rápido: Q1 e Q2

Q1.

Mulher, 78a, multimorbidade. Diz que “toma banho sozinha”, mas a filha relata dar banho há 3 meses. Qual a conduta correta na AGA?

- A) Registrar independente, pois ela afirma
- B) Registrar dependente: vale o desempenho real
- C) Ignorar a queixa do familiar
- D) Repetir só daqui a 1 ano

Q2.

Homem, 80a, perdeu 5 kg em 3 meses, parou de cozinhar. Qual o melhor instrumento de rastreio nutricional?

- A) Escala de Barthel
- B) MEEM
- C) Mini Avaliação Nutricional (MAN)
- D) Índice de Katz

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q3. Idoso “sem tristeza”, com dor difusa, insônia e anorexia. Rastreo de humor indicado?

Q4. Cuidadora exausta, cuida sozinha da mãe acamada. Que escala quantifica a sobrecarga?

Q5. No hospital de transição, melhor momento para a AGA breve, por quê?

Gabarito comentado

Q1 → B — Katz/Barthel medem desempenho real; “habilidade” declarada engana. (A/C/D ignoram o relato e a perda funcional.)

Q2 → C — MAN é o rastreo nutricional. Barthel/Katz = funcional; MEEM = cognição.

Q3 → EGD-15 — Depressão atípica: somatização, insônia, anorexia, sem “tristeza”.

Q4 → Zarit — Quantifica sobrecarga do cuidador → aciona rede formal.

Q5 — Paciente estabilizado + tempo + meta de alta = avaliar e agir com impacto.

Recapitule agora — e revise de novo nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- As 3 dimensões de hoje e a frase-âncora
- 2 instrumentos de ABVD e 2 de AIVD
- Cortes da MAN e da EGD-15
- Por que a AGA breve cabe no hospital de transição



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Qual AVD (básica ou instrumental) se perde primeiro — e por quê?
2. Como diferenciar desnutrição de sarcopenia na prática?
3. Cite 3 vantagens da AGA breve no hospital de transição.

Referências

1. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(9):CD006211.
2. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Avaliação Geriátrica Ampla (AGA): instrumento e material de educação continuada. SBGG.
3. Moraes EN, Carmo JA, Moraes FL, Azevedo RS, Machado CJ, Montilla DER. Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20 (IVCF-20). Rev Saúde Pública. 2016;50:81.
4. Moraes EN, Lanna FM. Avaliação multidimensional do idoso / Modelo de funcionalidade global. (Nova AGA, SBGG, 2023).
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2022 — população por idade e sexo.
6. Katz S, et al. Studies of illness in the aged. The index of ADL. JAMA. 1963;185:914-9.
7. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9:179-86.
8. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J. 1965;14:61-5.
9. Yesavage JA, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale. J Psychiatr Res. 1982-83;17:37-49. (Validação BR: Almeida OP, Almeida SA. Arq Neuropsiquiatr. 1999.)
10. Smilkstein G. The Family APGAR. J Fam Pract. 1978;6:1231-9. · Zarit SH, et al. Gerontologist. 1980;20:649-55.

Pontos de corte das escalas conforme o instrumento AGA-SBGG fornecido; validações brasileiras devem ser conferidas na versão de cada instrumento.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Ícones: Font Awesome (react-icons), licença livre (CC BY 4.0 / SIL OFL), uso com atribuição. **Diagramas, esquemas e gráficos:** originais, criados para esta aula (sem figuras protegidas).



Marca institucional: logo oficial da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (CMMG / FELUMA), de uso institucional, aplicado na capa. Paleta institucional FCMMG (teal/dourado/marinho) em toda a aula.

Obrigado!

O idoso se mede pelo que **FAZ**, pelo que **COME** e por **COM QUEM CONTA**.

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG



FACULDADE
CIÊNCIAS
MÉDICAS
É NOTA

★★★★★

5 MÁXIMA

NO MEC

FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
LUCAS MACHADO
FELUMA

FCMMG
FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA
1950